

Fecha Última Actualización: 25-02-2023 16:41:51

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juan Oscar Muñoz Moreira

Rut : 8.063.549-4

N° Archivo : 2217255

N° Epicrisis
320586

Edad : 64a 11m 17d

Fecha Nacto: 08/03/1958

Sexo : Masculino

Dirección : Navarra #4160, Villa Plazuela Los Toros

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 989078218

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 25/08/2022 04:42

Días Estadía: 184

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 25/02/2023 16:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Stroke

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre : Juan Muñoz Mo

Edad : 64 años

RUT : 8063549-4

FI HSR : 25-08-22

FI UTAC : 25-08-22

FI UPC : 05-09-22

FI UTIM 4ª : 20-12-22

Antecedentes:

- Médicos: HTA, DM2

- Quirúrgicos: (-)

- Fármacos: Metformina 850 mg día, Atorvastatina 20 mg día, Losartan

- Alergias: no

- Hábitos: OH ocasional TBQ (-) Otras drogas (-)

- Sociales: Pintor en desabolladura, vive con esposa e hijos, escolaridad media incompleta.

- Hospitalizaciones: (-)

Anamnesis Próxima:

En buenas condiciones hasta el día de ingreso cuando presentó déficit motor de hemicuerpo derecho en relación a hematoma talámico izquierdo con vaciamiento ventricular ICH 1. Se realiza manejo inicial en UTAC donde presentó shock séptico de foco respiratorio con aumento en requerimientos de oxígeno, hipotensión y foco de condensación basal D° requiriendo progresión en soporte ventilatorio e iniciando VMi el 05-09 por lo que se trasladó a UPC para continuar manejo. Evolución por planes y problemas en UPC

Hemodinámico: durante estadía en UTAC con requerimiento de terapia vasodilatadora endovenosa para control de presión, posteriormente y en relación a intercorrenza infecciosa inicial requirió noradrenalina a dosis intermedia (NA 0.1 mg kg hr) con posterior titulación a la baja hasta suspensión. Posteriormente evoluciona con tendencia a hipertensión requiriendo inicio de terapia vasodilatadora oral. Una vez en fase de rehabilitación se mantuvo normotenso con diuresis y perfusión conservada.

Respiratorio: Requerimiento de VMi por shock séptico, posteriormente perpetuado por neuropatía sensitivo-motora severa. Se

Fecha Epicrisis : 25/02/2023 16:41

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 25-02-2023 16:41:51

Página 2 de 4

realizó TQT percutánea #8 el 21-09 sin incidentes y se mantuvo en rehabilitación multimodal, con requerimiento de VMI por TQT hasta el 17-12. Desde entonces con TQT en filtro sin nuevo requerimiento de conexión a VMI

En lo kinésico logra paso a sillón con asistencia máxima tolerando 2 hrs, se describe aspiración de secreción mucopurulenta abundante.

Desde el punto de vista fonoaudiológico logra fonación con VF por 5 minutos sin mayor progresión en otras terapias por falta de cooperación del paciente

Infeccioso: presentó tres grandes interurrencias infecciosas.

-Shock séptico de foco pulmonar por neumonía obs aspirativa de LID° por E coli (R) a ampicilina/sulbactam (CAET 05-09). Completó 3 días de vancomicina, 6 días de meropenem con posterior ajuste acorde a sensibilidad a ceftriaxona completando un total de 10 días de antibioterapia

-Traqueítis por E coli MS (CAET 25-09) completó 7 días de ceftriaxona

-Traqueítis por E coli MS (CAET 26-10) completó 7 días de ceftriaxona

-ITU CUP E faecalis y Traqueítis por E coli y SAMS (CAET y UC 19-11), completó finalmente 7 días de antibioterapia combinada con ampicilina y ciprofloxacino.

-Traqueítis por SAMS (CAET 10-12), completó 5 días de linezolid

Neurológico: durante estadía en UPC se mantuvo en seguimiento por equipo de neurología con medidas de neuro protección secundaria. El 12-09 y tras 5 días de suspensión de sedación se constató paciente tetraparético sin gatillo de ventilador lo que motivó el estudio con

-Estudio de LCR 14-09 PL: Cs: 33/ Prot: 1,96/ Gluc: 122/ cultivo negativo

-RM de encéfalo 15-09: Hematoma parenquimatoso conocido, lesiones isquémicas sub agudas frontales izquierdos, secuelas micro hemorrágicas supra e infratentoriales de localización central.

Quedó en plan de realización de EMG con VCN previo a lo cual recibió administración de Inmunoglobulina Humana 30 gr x 4 días y 20 gr x 1 día a partir del 15-09.

Evoluciona posteriormente con crisis convulsiva, se realizó EEG (25-09) lentitud continua hemisférica izquierda, frecuente lentitud intermitente generalizada, DLGG) que se interpretó como no irritativo e inició Levetiracetam 1 gr día

Finalmente se concretó realización de EMG (30-09: que evidenció ausencia de potenciales motores y sensitivos con artefacto de ruido) que se interpretó como una neuropatía sensitivo-motora severa sugerente de Sd de Guillain B arré.

Se mantuvo en plan de realización de gastrostomía y en rehabilitación multimodal.

Nefrológico: durante la hospitalización presentó tendencia a la hipokalemia, en concomitancia con administración de furosemida para lograr BH negativo, requiriendo carga endovenosa.

Evolución en UTIM 20/12 - 20/01:

Hemodinamia: Con episodio de shock séptico reciente, NAD hasta dosis moderadas suspendida hace más de 1 semana. Actualmente sin conflicto. Hb estable, no ha requerido soporte transfusional. Destaca 17/01 episodio de taquicardia sinusal hasta 130 (en ECG) e hipotensión, sin un gatillante claro, autolimitada ¿crisis disautonómica? No se ha repetido.

Respiratorio: Cursó con insuficiencia respiratoria, a su ingreso a UTIM ya resuelta. TQT cambiada 25/12.

Infeccioso: Múltiples interurrencias durante la hospitalización ya descritas. Durante estadía en UTIM destaca traqueobronquitis por SAMS y E. coli resistente a cefazolina/pip/tazo (CAET 20-12). Completó 7 días de Ceftriaxona el 31/04, manteniendo Cefazolina. 04/01 con shock séptico de presumible foco pulmonar. Destaca CAET 30/12 KPN BLEE, CAET 04/01 (+) KPN BLEE, SAMS y E. coli, por lo que se ajustó tto a Imipenem, completó 14 días de Imipenem 17/01.

Neurológico: Ingresó por ACV hemorrágico talámico izquierdo, se constató durante la hospitalización AIDP obs Sd de Guillain Barré recibiendo 5 días de inmunoglobulinas (a partir del 12-09). Reevaluado 18/01 con neurología, indican que no requiere mayor estudio actualmente, déficits explicables por hematoma talámico izquierdo y Guillain Barre. Respecto a pronóstico (aunque usando score mEGOS que considera SGB al ingreso y no ACV), tendría menos de 50% de probabilidad de caminar sin asistencia a los 6 meses.

Rehabilitación:

- FNA y nutricional: El 25/12 se realiza cambio de TQT a #8 con puerto subglótico. Mantiene irregular tolerancia a VF, sólo durante terapia FNA/KNT, por 20 minutos aprox. GTT instalada 17/01.

Fecha Epicrisis : 25/02/2023 16:41

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 25-02-2023 16:41:51

Página 3 de 4

- KNT: Logra pasar a sillón con buena tolerancia.
- Nutricional: Dado mejoría de prealbúmina, se sugiere mantener prescripción nutrición enteral actual. Control semanal de prealbúmina, última en 16.

Metabólico: Regular control glicémico, en seguimiento para ajuste de esquema de insulina. En tratamiento con Lantus asociado a esquema prandial.

Evolución en sala básica (21/01/23 - 09/02/23):

Hemodinamia: Cursa con hipertensión leve, se inicia BB dosis a bajas el 31/01 con buena respuesta, bien tolerado.

Respiratorio: Sin interurrencias, requiere de forma intermitente O2 suplementario.

Infeccioso: El 03/02 presenta peak febril aislado hasta 37.8°, del estudio destaca: SO con piuria 15-20/campo, UC (+) K. Pneumoniae BLEE > 100.000 UFC, HC I y II (-), PCR Covid 19 (-), panel viral respiratorio (-). Se inició Imipenem (04 - 07/02) + Vancomicina (04 - 06/02), se ajusta esquema a Amkacina (FI 07/02) según antibiograma. Evoluciona subfebril, con parámetros inflamatorios al alza, por lo que se solicita PieloTC (p).

Neurológico: En cuanto al pronóstico de su ACV, su proceso de rehabilitación se ha visto en gran parte mermado por las interurrencias infecciosas, la miopatía adquirida y además el SGB mismo, su ventana de rehabilitación es acotada. A sugerencia de medicina física recibiendo sertralina como estimulador cognitivo

El 07/02 presenta evento de clonías asociado a desconexión con el medio de corta duración (1-2 min), sin período post ictal significativo. Evaluado por especialidad, impresiona síncope convulsivo. Durante la tarde del mismo día presenta nuevo episodio, asociado a desaturación hasta 22%, PA 160/100, con compromiso de consciencia por 20-30 min (apertura ocular espontánea, pero sin respuesta frente a estímulo doloroso). Se solicitó TAC de cerebro que impresionó sin cambios respecto a imagen previa (sin informe). Reevaluado por especialidad, impresiona crisis comicial obs reactiva a interurrencia infecciosa y uso de imipenem. Se inicia levetiracetam y se solicita E E G, reevaluación por especialista una vez superada interurrencia.

Crítico crónico:

- TQT: se cambia TQT a #7.5, en seguimiento por FNA mantiene VF terapéutica, secreciones en regular cantidad.
- KNT: Se pasa a sillón con máxima asistencia, sin control del tronco. Progresión estacionaria, con poca cooperación por parte del paciente.
- Deglución: GTT del 17/1, trastorno de deglución severo.
- Nutrición: Recibiendo nutrición enteral 30 kcal/kg/día. Prealbúmina (02/02): 21

Metabólico: Buen control glicémico con IC correccional, se mantiene sin basal, objetivo cercano a 180 mg/dl.

Diagnósticos de traslado:

- Crítico crónico
- Tetraparesia - polineuropatía sensitivo motora severa y polimiopatía
 - AVE hemorrágico con HIC talámica izquierda ICH 1
- Síndrome de Guillain Barré
- ITU por K. Pneumoniae BLEE en tratamiento
- Crisis comicial reactiva (ITU + imipenem)
- Miopatía del paciente crítico
- Usuario de GTT y TQT (VMI prolongada)
- Insuficiencia respiratoria aguda en resolución
- Desnutrición CP severa
- Delirium hipoactivo
- Hits resueltos: Múltiples interurrencias por E. coli, S. aureus MS, E. faecalis, K. pneumoniae BLEE, Sd. convulsivo 2°.
- Antecedentes: HTA, DM2 NIR.

Diagnóstico de Egreso

Hematoma Talámico Izquierdo Con Vaciamiento Ventricular (Ich 1) -
Hematoma Cerebral Intraparenquimatoso Etiología Hipertensiva -
Neumonía Aspirativa (Macroaspiración) -

Fecha Epicrisis : 25/02/2023 16:41

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 25-02-2023 16:41:51

Página 4 de 4

Atelectasia Inferior Derecha -
Insuficiencia Respiratoria Grave -
Intubación Endotraqueal Y Asistencia Por Vmi -
Catéter Venoso Central Derecho -

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

En regulares condiciones, hemodinamia estable, afebril, requerimientos bajos e intermitentes de O2. Mantiene vigilia, con plejía derecha y hemiparesia izquierda M2. Sólo tolera VF hasta 20 minutos.

Plan Post Alta

Actualmente en rehabilitación multimodal, mantener VF sólo durante terapia con KNT y FNA. Pendiente traslado a H. San José de Maipo para continuar rehabilitación.

INDICACIONES.

Reposo relativo, pase a sillón por KNT
Régimen Enbrace Intensivo a 60 cc/h + agua libre 50 ml/h GTT
O2 para sat 92%
HGT cada 6 horas + IC correccional >180
KTM, KTR, FNA
Colchón anti-escaras
Mantener TQT, GTT
Sondeo post miccional
Curaciones UPP

Levetiracetam 1 g c/12 hrs por GTT
Pregabalina 75 mg/noche GTT
Omeprazol 40mg al día EV
Enoxaparina 40 mg/día SC
Atropina 1 ampolla/10 cc sf, dar 1 cc a las 16:00 y en la noche.
B ipratropio 1 puff cada 8 hrs directo en la boca
Sertralina 25 cada 24 hrs x GTT
Carvedilol 3.125 mg cada 12 hrs x GTT
Enalapril 5mg cada 12 hrs x GTT

SOS:

- Paracetamol 1g, máximo c/8 h x GTT, en caso de fiebre y/o dolor
- Metamizol 1g EV, máximo c/8 hrs (si no responde a paracetamol)
- Metoclopramida 10 mg EV

Indicaciones

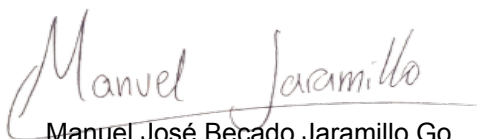
Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Enbrace Intensivo 60 Cc/Hr + Agua Libre 50 Cc/Hr Por Gtt

Medicamentos :

Controles

INTERNO


Manuel José Becado Jaramillo Go
Becado/Residente


Ada Cascone Scarpatti
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 25/02/2023 16:41

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:58

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar